

09 - 01-Gestes et soins d'urgences niveau I - Pr. T.ABOU ELHASSAN

(0:00 - 1:08)

Nous allons présenter aujourd'hui le sous-module de secourisme entrant dans le cadre du module médecine expérimentale sur les gestes et soins d'urgence niveau 1, le GSU1, pour la deuxième année de médecine. Au début, le sous-module se comporte des actes suivants alerte et protection, arrêt cardiaque, obstruction des voies aériennes supérieures, l'hémorragie et le patient inconscient. Les objectifs pédagogiques de ce module, c'est connaître les différentes situations d'urgence inopinées, comprendre le processus d'alerte et de protection, savoir émettre un message d'alerte devant une situation d'urgence inopinée, savoir évaluer l'état de la victime et prioriser la prise en charge, maîtriser les gestes élémentaires de sauvetage, notamment le massage cardiaque externe, la désobstruction des voies aériennes supérieures, la pollution latérale de sécurité, la PLS, la compression et d'autres gestes élémentaires.

(1:09 - 1:48)

Comme guide d'introduction, nous sommes tous confrontés, notamment le médecin, à certaines urgences inopinées, soit dans le milieu professionnel ou parfois en dehors des structures de soins. Dans ce contexte-là, les moyens de prise en charge purement médicales sont très limités, en dehors de l'hôpital, et le médecin est généralement isolé, doit mettre en œuvre les gestes de premier secours en y associant son expertise médicale. Le premier chapitre, c'est alerte et protection.

(1:49 - 2:16)

Avant de démarrer ce chapitre-là, il y a certains préalables à toute action de secours. Premièrement, il faut protéger dans un premier temps la victime et le sauveteur. Il faut procéder au dégagement d'urgence de la victime, faire un bilan, alerter les secours médicalisés, et entamer les gestes d'urgence avant que le secours vienne chez le médecin ou chez le professionnel de santé.

(2:16 - 2:42)

Les règles d'alerte et protection sont faites sous forme PAS, donc il faut protéger, alerter et donner secours. La protection de la victime et du sauveteur se fait au niveau de la détresse ou sur le lieu de la détresse. Il faut toujours chercher un danger de sur-accident.

(2:43 - 3:10)

Protéger la zone d'accident type triangle, feu d'étresse, et protéger les témoins aussi. Placer en amont et en aval du lieu de l'accident à environ 200 mètres en tenant compte des conditions de

visibilité lors d'un accident de la voie publique. Et devant un accident domestique, il faut vérifier la présence de fil électrique, d'odeurs de gaz, de matériaux menaçants de chuter.

(3:11 - 3:47)

Quel serait notre conduite à tenir? Premier élément, il faut reconnaître le danger. En effectuant une approche prudente de la zone d'accident ou de la zone où il y a l'incident, il faut rester à distance de la victime, regarder tout autour de la victime et se renseigner s'il y a des témoins auprès de ces témoins. Deuxième élément, délimiter de façon claire, large et visible la zone dite de danger pour empêcher toute intrusion dans cette zone par des témoins.

(3:48 - 4:08)

Jusqu'au là, ils sont indemnes et cela va éviter le principe de sur-accident lorsque des témoins vont être introduits au niveau de cette zone. Deuxième élément, procéder au dégagement de la victime en urgence. Le dégagement est un élément important.

(4:09 - 4:46)

Devant l'impossibilité de supprimer un danger vital réel, il faut soustraire la victime sans délai s'il ne peut pas le faire elle-même. Plusieurs techniques antidélicrites, soit avec ou plusieurs sauveteurs, les moyens sont généralement les tractions par les poignets, la traction par les chevilles ou parfois l'extraction d'une victime dans un véhicule. Toutes ces techniques ont pour principe de préserver l'axe tête-coup-trans d'une façon rectiligne.

(4:47 - 5:07)

Ces techniques sont généralement complexes et montrent rapidement leurs limites. Dans ce cas-là, s'il y a une extraction rapide, l'efficacité prime sur la technique en elle-même. Sur ces diapositives-là, on présente deux façons de dégager la victime.

(5:08 - 5:35)

Sur l'image à gauche, on montre la traction pour dégager la victime en s'aidant par les poignets. La deuxième image à droite montre une technique de dégagement en faisant une traction par les chevilles. Un sauveteur dans ce cas-là, pour ce dégagement, doit respecter certains principes.

(5:35 - 6:09)

Premier principe, il faut choisir la technique de dégagement en tenant compte de sa force physique. Il faut saisir solidement la victime soit par les poignets, soit par les chevilles et la tirer par le sol, quelle que soit sa position, jusqu'à qu'elle soit en lieu sûr, loin du danger et des conséquences de ce danger. Et finalement, il ne faut pas hésiter à se faire aider éventuellement par une tierce personne.

(6:12 - 6:49)

Dans le cas où c'est vraiment impossible de supprimer le danger et de dégager la victime, il faut alerter ou faire alerter les secours spécialisés par une autre personne. Il faut assurer une surveillance permanente de la zone de danger où les risques non contrôlés persistent et empêcher toute personne de pénétrer dans cette zone jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés. Le sauveteur doit en priorité assurer sa sécurité dans un premier tas, puis celle des témoins dans un deuxième tas et celle de la victime dans un troisième tas.

(6:50 - 7:05)

Les règles de priorité doivent être exécutées de cette façon. Le sauveteur, puis le témoin, puis la victime. Quelques cas particuliers qui émanent de la vie quotidienne.

(7:05 - 7:31)

Premier cas, lorsqu'on est devant un accident de route, si on est en voiture. En cas d'accident de la route sur une route principale ou une autoroute, si on est dans une voiture, il faut allumer ses feux de détresse dès qu'on est en vue d'un accident et il faut ralentir. Il faut garer le véhicule si possible après le lieu de l'accident.

(7:32 - 7:44)

Sur la bande d'arrêt d'urgence, il existe généralement à droite. Veillez à faire descendre immédiatement tous les occupants de son véhicule. Et les mettre en sécurité sur le bas côté.

(7:45 - 8:32)

Et faire ce qu'on appelle un balisage de part et d'autre d'accident entre 150 et 200 m. Le but c'est éviter tout sur-accident en mettant des triangles de pré-signalisation, des lampes électriques, des lignes blanches, des feux détresse de véhicules avec l'aide de témoins éventuels. Dans ce cas-là, il faut aussi interdire toute approche si un danger persiste, notamment quelqu'un qui fait un transport de matières dangereuses ou qui sont inflammables. Il faut surtout ne pas fumer et surtout ne pas laisser fumer en présence d'un feu naissant dans un comportement moteur et utiliser un extincteur.

(8:32 - 8:51)

Et finalement couper le contact des voitures accidentées dans la limite du possible. Deuxième cas de figure, protection dans d'autres situations. On vous propose un cas où il faut pénétrer dans un local enfumé et non ventilé.

(8:51 - 9:12)

Dans ce cas-là, il faut ralentir sa respiration pour diminuer l'inspiration des gaz ou de fumée qui est généralement toxique. La durée de manœuvre ne doit pas excéder 30 secondes. Pour pénétrer en cas d'incendie, il faut protéger au maximum avec ses vêtements et se couvrir le visage et les mains.

(9:12 - 9:39)

Si, en synthèse, il y a un risque d'explosion par fuite de gaz, il ne faut surtout pas provoquer d'étincelles. Et en cas de danger électrique, il faut rapidement, dans la limite du possible, couper le courant avant de toucher l'invictive par risque d'électrocution. Dans ce cas-là, il faut immédiatement se mettre à l'abri en s'enfermant dans un local.

(9:41 - 9:51)

Deuxièmement, écouter la radio sur un poste alimenté par des piles. Ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Ne pas fumer, éviter toutes flammes ou étincelles.

(9:51 - 10:20)

Il faut fermer les gaz, ne pas téléphoner pour ne pas encombrer le réseau qui doit rester libre pour les secours. Et lorsque le danger est acté, la sirène va diffuser un signal sonore continu de 30 secondes lorsque le bâtiment est équipé par ce système de détection de fumée. Troisième élément, comment faire le bilan de la victime.

(10:20 - 10:58)

Le bilan de la victime nécessite une analyse rapide de la situation d'urgence et de l'état des fonctions vitales de la victime, essentiellement la conscience, la respiration et l'état circulatoire. Une fois le bilan fait, vient l'étape suivante qui est l'alerte. L'alerte est définie comme étant une action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou de plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses, ainsi que la nature d'assistance qui leur est appropriée.

(10:58 - 11:28)

Les alertes ou l'alerte des secours médicalisés ne doit pas se faire retarder les gestes de sauvetage face à une détresse vitale immédiate, notamment un patient en arrêt cardiaque. Il faut démarrer la réanimation cardiopulmonaire de base. Une fois le geste salvateur effectué, il convient d'appeler les services compétents, notamment la protection civile, la gendarmerie royale, la police ou le service d'aide médicale urgente, le SAMU.

(11:30 - 11:47)

Pourquoi il faut faire ça ? Il y a des justifications. Première justification, c'est que la vie de toute personne peut un jour ou l'autre être menacée par un accident. Deuxième justification, il existe

plusieurs structures publiques ou privées adaptées à ces détresses.

(11:48 - 12:18)

Chacune a un rôle bien précis. Troisième élément justificatif, c'est que toute personne témoin d'une situation de détresse doit, après avoir protégé, alerté les secours et pratiqué les gestes simples, pouvoir conserver une vie en attendant l'arrivée des secours spécialisés. Par quelle manière on va communiquer ? L'alerte des secours peut être réalisée à l'aide d'un téléphone fixe, un téléphone mobile, un cabinet téléphonique ou par une bande d'appels.

(12:19 - 12:45)

Par exemple, au niveau des autoroutes, il y a des bandes d'appels sur lesquelles on peut appeler. Ce qui fait ou cela va faire par le sauveteur et par l'intermédiaire d'une tierce personne. L'alerte peut être faite soit par le sauveteur, soit par une tierce personne à qui on donne des consignes d'appel qui viennent rendre compte une fois l'alerte donnée.

(12:46 - 13:32)

Mais comment faire l'alerte et quels sont ces signes d'appel ? Mais quels sont les messages sur lesquels on va faire passer lorsqu'on va appeler ? Le contenu des messages d'alerte, lorsqu'on fait un contact avec ce qu'on appelle le centre de régulation des appels médicaux, le CRAM, un certain nombre de renseignements sont indispensables. Premièrement, quel est le problème et quels sont les risques éventuels ? Deuxième élément, le nombre des victimes, c'est un élément important, et l'état de gravité des victimes. Est-ce que la victime est consciente ? Est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle respire ? Ou est-ce qu'elle est complètement en arrêt cardiaque ? La réalisation ou les gestes à faire entamer par la suite sont complètement différents.

(13:33 - 14:15)

La localisation de l'incident d'une façon précise ou d'une façon la plus précise possible. Quelle ville ? Quel bâtiment ? Quel numéro de la rue ? Quel code d'entrée lorsqu'on est devant un bâtiment ? Et dernièrement, le numéro de téléphone, de contre-appel, c'est le numéro de téléphone par lequel le sauveteur ou la tierce personne, les témoins, ont appelé pour essayer de le rappeler secondairement. Ces appels doivent être faits ou effectués par des numéros dits d'urgence qui sont actuellement connus et qui doivent être connus par tout le monde.

(14:15 - 14:37)

Le numéro 15, c'est le numéro unique et gratuit pour joindre le centre opérationnel départemental des sapeurs-pompiers et des ambulances. Le numéro 19, c'est le numéro de la sûreté nationale. Le numéro 177, c'est le numéro de la gendarmerie royale lorsqu'on est dans un secteur de la gendarmerie royale qui est géré par la gendarmerie royale, notamment dans le milieu rural.

(14:37 - 14:45)

Et le numéro 141, c'est le numéro de SAMU, le service d'aide médicale urgente. Le numéro 144, c'est le numéro de la gendarmerie. Le numéro 145, c'est le numéro de la gendarmerie.